

Exploracion y estratificacion del pie de riesgo en personas con diabetes

DATOS DEL PACIENTE

|                     |          |                    |          |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| Nombre y apellidos: |          | NUHSA:             |          |
| Fecha nacimiento:   | __/__/__ | Fecha exploracion: | __/__/__ |
|                     |          | Profesional:       |          |

1. ANTECEDENTES PERSONALES

|                                               |               |                                      |                          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Úlcera previa en pie                          | [ Si ] [ No ] | Neuropatía diagnosticada             | [ Si ] [ No ]            |
| Amputación previa de miembro inferior         | [ Si ] [ No ] | Enfermedad arterial periférica (EAP) | [ Si ] [ No ]            |
| Cirugía vascular o revascularización previa   | [ Si ] [ No ] | Insuficiencia renal crónica          | [ Si ] [ No ]            |
| Deformidades previas tratadas quirúrgicamente | [ Si ] [ No ] | Retinopatía diabética                | [ Si ] [ No ]            |
| Años evolución DM:                            |               | Tipo DM:                             | [ DM1 ] [ DM2 ] [ Otra ] |
|                                               |               | HbA1c:                               | % Fecha: __/__/__        |

2. HISTORIA ACTUAL — NEUROPATIA

|                                                 |               |                                                  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Parestesias o disestesias en pies               | [ Si ] [ No ] | Pérdida de sensibilidad referida por el paciente | [ Si ] [ No ] |
| Dolor neuropático (quemazón, pinchazo nocturno) | [ Si ] [ No ] | Calambres nocturnos en EEII                      | [ Si ] [ No ] |
| Sensación de frío o calor permanente            | [ Si ] [ No ] | Debilidad o pérdida fuerza distal                | [ Si ] [ No ] |

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Monofilamento S-W 10g          | Pie derecho               | Pie izquierdo             |
| Punto 1: 1er dedo              | [ Normal ] [ Alterado ]   | [ Normal ] [ Alterado ]   |
| Punto 2: Base 1er metatarsiano | [ Normal ] [ Alterado ]   | [ Normal ] [ Alterado ]   |
| Punto 3: Base 5o metatarsiano  | [ Normal ] [ Alterado ]   | [ Normal ] [ Alterado ]   |
| RESULTADO                      | [ NORMAL ] [ NEUROPATIA ] | [ NORMAL ] [ NEUROPATIA ] |
| Diapason 128 Hz                | [ Normal ] [ Alterado ]   | [ Normal ] [ Alterado ]   |

3. ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA (EAP)

|                                            |               |                                 |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Claudicación intermitente al caminar       | [ Si ] [ No ] | Cicatrización lenta de heridas  | [ Si ] [ No ] |
| Dolor en reposo en extremidades inferiores | [ Si ] [ No ] | Cambios tróficos en piel o uñas | [ Si ] [ No ] |
| Frialdad / palidez / cianosis en pies      | [ Si ] [ No ] | Ausencia de vello en EEII       | [ Si ] [ No ] |

|                          |                                    |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Palpación de pulsos      | Pie derecho                        | Pie izquierdo                      |
| Pulso tibial posterior   | [ Presente ] [ Ausente ] [ Débil ] | [ Presente ] [ Ausente ] [ Débil ] |
| Pulso pedio              | [ Presente ] [ Ausente ] [ Débil ] | [ Presente ] [ Ausente ] [ Débil ] |
| ITB (si ausencia pulsos) | ITB derecho: _____                 | ITB izquierdo: _____               |

4. HABITOS DE CUIDADO DEL PIE

|                                                    |               |                                                       |               |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Inspecciona los pies diariamente                   | [ Si ] [ No ] | Usa calzado adecuado, cerrado y sin costuras internas | [ Si ] [ No ] |
| Lava con agua tibia y seca entre dedos             | [ Si ] [ No ] | Usa calcetines sin costuras ni elásticos              | [ Si ] [ No ] |
| Hidrata los pies regularmente (no entre dedos)     | [ Si ] [ No ] | Corta las uñas rectas (no en curva)                   | [ Si ] [ No ] |
| Consulta al equipo sanitario ante cualquier herida | [ Si ] [ No ] | No camina descalzo ni en interior del domicilio       | [ Si ] [ No ] |

5. EXPLORACION FISICA DEL PIE

|                                                  |               |                                                    |               |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Callosidades / hiperqueratosis                   | [ Si ] [ No ] | Deformidad: dedos en garra / hallux valgus         | [ Si ] [ No ] |
| Grietas o fisuras plantares                      | [ Si ] [ No ] | Cambios de coloracion o temperatura local          | [ Si ] [ No ] |
| Micosis interdigital o ungueal                   | [ Si ] [ No ] | Alteracion de unas (onicogrifosis, onicocriptosis) | [ Si ] [ No ] |
| Lesion o ulcera activa (ver clasificacion Texas) | [ Si ] [ No ] | Edema en pies o tobillos                           | [ Si ] [ No ] |

Observaciones de la exploracion fisica:

6. CLASIFICACION DEL RIESGO Y PLAN DE ACTUACION

| RIESGO   | CRITERIOS PRINCIPALES                                                                                     | SEGUIMIENTO       | RESULTADO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| BAJO     | Sin neuropatia, sin EAP, sin deformidades, sin antecedentes ulcera/amputacion                             | Cribado ANUAL     | [ ]       |
| MODERADO | Neuropatia O EAP, sin ulcera previa. Puede asociarse a deformidad, tabaquismo o limitacion de autocuidado | Cribado SEMESTRAL | [ ]       |
| ALTO     | Ulcera o amputacion previa OR isquemia (ITB <0,9 o >1,3) OR neuropatia con deformidad o EAP               | Cada 1-3 MESES    | [ ]       |

Plan de actuacion e intervenciones recomendadas:

|                    |                                  |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Firma profesional: | Proxima revision: ____/____/____ | Derivacion: [ Podologia ] [ Cirugia Vascular ] [ Endocrinologia ] [ Otro ] |
|                    |                                  |                                                                            |